



中国医院统计
Chinese Journal of Hospital Statistics
ISSN 1006-5253, CN 37-1254/C

《中国医院统计》网络首发论文

题目：团体叙事心理干预对青少年抑郁症患者非自杀性自伤行为的影响
作者：潘建波，罗萍，潘逸群
收稿日期：2024-09-10
网络首发日期：2025-05-27
引用格式：潘建波，罗萍，潘逸群. 团体叙事心理干预对青少年抑郁症患者非自杀性自伤行为的影响[J/OL]. 中国医院统计.
<https://link.cnki.net/urlid/37.1254.c.20250526.1505.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

· 医疗数据统计 ·

团体叙事心理干预对青少年抑郁症患者 非自杀性自伤行为的影响

潘建波¹ 罗萍² 潘逸群³

1 绍兴市第七人民医院神经内科, 312000 浙江 绍兴;

2 绍兴市第七人民医院心身障碍二科, 312000 浙江 绍兴; 3 绍兴市第七人民医院党政办, 312000 浙江 绍兴

通信作者: 潘建波, Email: panjo5854@163.com

【摘要】目的 分析团体叙事心理干预对青少年抑郁症患者非自杀性自伤行为(non-suicidal self-injury, NSSI)的影响。**方法** 选取 2022 年 1 月至 2023 年 6 月在某医院治疗的 118 例青少年抑郁症患者, 随机分为 2 组, 对照组 59 例患者, 观察组 59 例患者。对照组患者采用常规护理, 观察组在常规护理基础上增加团体叙事心理干预。统计 2 组患者 NSSI 发生情况, 并对 2 组患者干预前后抑郁情绪、心理弹性及自尊水平。**结果** 干预后 3 个月, 观察组患者 NSSI 频次及对身体最严重的伤害程度均低于对照组患者($P < 0.05$); 干预前后, 对照组的 SDS 评分、HAMD 评分、CD-RISC 及 SES 评分差值分别为 (10.01 ± 2.15) 、 (6.91 ± 1.78) 、 (9.45 ± 2.54) 、 (7.08 ± 1.53) , 观察组分别为 (16.14 ± 3.02) 、 (10.08 ± 2.06) 、 (15.10 ± 2.86) 、 (11.75 ± 2.12) , 观察组差值均高于对照组($P < 0.05$)。**结论** 团体叙事心理干预可以改善青少年抑郁症患者的抑郁情况, 减少非自杀性自伤行为, 值得推广临床应用。

【关键词】 青少年; 抑郁症; 非自杀性自伤行为; 团体护理; 叙事护理

Effect of group narrative psychological intervention on non-suicidal self-injury behavior in adolescent depression patients

Pan Jianbo¹, Luo Ping², Pan Yiqun³. 1 Department of Neurology, Shaoxing Seventh People's Hospital, Shaoxing 312000, China; 2 Second Department of Psychosomatic Disorders, Shaoxing Seventh People's Hospital, Shaoxing 312000, China; 3 Party and Government Office, Shaoxing Seventh People's Hospital, Shaoxing 312000, China

【Abstract】Objective To analyze the effect of group narrative psychological intervention on non-suicidal self-injury behavior (NSSI) in adolescent depression patients. **Method** A total of 118 adolescent depression patients treated in a certain hospital from January 2022 to June 2023 were randomly divided into two groups: the control group of 59 patients and the observation group of 59 patients. The control group received routine nursing care, while the observation group received group narrative psychological intervention besides routine nursing care. The occurrence of NSSI in two groups of patients was statistically analyzed to compare their levels of depression, psychological resilience, and self-esteem before and after the intervention. **Results** Three months after the intervention, the frequency of NSSI and the degree of injury in the observation group patients were significantly reduced and lower than those in the control group patients ($P < 0.05$). Before and after the intervention, the differences in SDS score, HAMD score, CD-RISC score, and SES score in the control group were 10.01 ± 2.15 , 6.91 ± 1.78 , 9.45 ± 2.54 , and 7.08 ± 1.53 , respectively, while the differences in the observation group were 16.14 ± 3.02 , 10.08 ± 2.06 , 15.10 ± 2.86 , and 11.75 ± 2.12 , respectively. The differences of the observation group were higher than those of the control group ($P < 0.05$). **Conclusion** Group narrative psychological intervention can improve the depression situation of adolescent depression patients, reduce NSSI, and is worthy of clinical application.

【Keywords】 adolescent; depression; non-suicidal self-injury behavior; group nursing; narrative nursing

青少年抑郁的发病率逐年增加, 全球发病率 2% ~ 8%, 严重时会造成死亡^[1], 有研究报道 29.7% 的抑郁

DOI:10.3969/j.issn.1006-5253.2025.03.004

引用格式: 潘建波, 罗萍, 潘逸群. 团体叙事心理干预对青少年抑郁症患者非自杀性自伤行为的影响[J]. 中国医院统计, 2025, 32(3): 183-187.

PAN J B, LUO P, PAN Y Q. Effect of group narrative psychological intervention on non-suicidal self-injury behavior in adolescent depression patients [J]. Chinese Journal of Hospital Statistics, 2025, 32(3): 183-187. DOI:10.3969/j.issn.1006-5253.2025.03.004.



症患者伴有非自杀性自伤行为(non-suicidal self-injury, NSSI)^[2]。据统计,全球约有 14%~15% 的青少年至少实施过一次 NSSI,现已成为严重的社会问题^[3]。目前主要治疗目标是最大程度降低患者的病残率及自杀率,减轻临床症状,治疗方式主要是心理或药物治疗,但疗效较慢且复发率较高,因此了解青少年抑郁症患者的 NSSI 的危险因素及产生源头,降低自伤行为,提高生活质量对治疗具有重要意义^[4]。团体叙事心理干预是一种通过解构问题故事,构建发展故事和积极身份认同,树立良好愿景进而帮助患者实现成长的干预方法,能有效缓解患者不良情绪^[5]。本研究对青少年抑郁症患者采用团体叙事心理干预,分析其对 NSSI 的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取 2022 年 1 月至 2023 年 6 月在某医院治疗的青少年抑郁症患者,共纳入 118 例,采用随机数字表法将其随机分为 2 组,其中对照组患者 59 例,研究组患者 59 例。纳入标准:①患者年龄 12~18 周岁;②符合 ICD-10 青少年抑郁症诊断标准^[6];③首次住院治疗,且在过去 1 年内至少有 1 次 NSSI;④可以配合完成本研究。排除标准:①治疗前 3 个月有心理治疗史;②合并重要器官功能障碍、恶性肿瘤等;③合并躁狂症、自闭症、智力障碍及其他精神/心理类疾病;④严重躯体疾病。患者及其家长均对本研究知情且同意,且经绍兴市第七人民医院伦理委员会审批通过(2023-031-01)。

1.2 研究方法

1.2.1 对照组

对照组患者采用常规护理,患者接受常规药物及物理治疗,护理人员给予患者常规安全性评估、自伤风险评估及管理、情绪疏导等干预。

1.2.2 观察组

观察组在对照组基础上增加团体叙事心理干预。

(1)成立干预小组,由精神科主治医师 1 名、心理治疗师 2 名、精神科专科护理人员 2 名组建干预小组,负责团体干预方案制定、实施、追踪及效果评价。团体叙事心理干预包括对心理状态进行评估和干预,个人心理状态评估以面对面单独访谈形式进行,时间在 60 min 左右,共 1 次;团体叙事心理干预将患者以每组 5 人进行分组,每次干预时由 1 名患者作为“分享

者”,其余 4 名为“观察者”,患者依次轮流作为分享者及观察者参与干预,每周四、周六分别进行 1 次干预,干预时长为 90 min,共 6 次,均于院内进行干预。

(2)个人心理状态评估:阅读患者个人资料,了解患者病情及治疗情况,掌握患者抑郁及自伤行为的原因,对于需要进一步了解的信息在访谈开始前进行整理,在与患者沟通中完成收集。在访谈中向患者讲解抑郁的诱发因素及自伤行为的原因和表现,交谈过程中面带微笑,尽量避免使用专业术语,鼓励患者说出自身感受、治疗经过、家庭及人际交往情况,引导患者说出生活变化并放松患者情绪,减轻其心理压力,在此过程中对患者进行针对性引导及反馈。向患者讲解团体叙事心理干预流程及具体方法,取得患者理解及同意。

(3)团体叙事心理干预:根据叙事疗法实践具体步骤^[7],包括:解构、问题外化、探索结果、重构、界定等,制定团体叙事心理干预具体方案。①第 1 次干预:主要为建立团体、建立接下来干预中“分享者”顺序,鼓励患者通过自我介绍、叙述当前的生活状态与感受等引导患者相互认识及接纳队友,在医护人员的协助下形成团队互助意识,以团队游戏的方式促进患者间感情交流、尽快破冰,组建微信群,方便患者间沟通交流。②第 2~6 次干预流程:医护人员自拟叙事访谈提纲,包括患者接受叙事干预的体验及感受、想法、对自伤行为的影响等,干预结束后进行小组总结并修改接下来的叙事干预方法。每一次团体干预实施前,首先进行 5~10min 结构性访谈,包括询问患者心理状态、自伤行为原因、想要探讨及了解的部分、被他人忽略的片段等。医护人员根据不同的患者问题进行针对性引导,主要围绕亲子关系、同伴关系、自我认知等引出患者存在的问题进行 30min 左右的叙事问话,例如不被父母理解、成绩不理想、被孤立、遭受语言及身体暴力等,将问题进行命名,帮助患者将问题与自身分离,感受问题不存在时的优点,帮助患者寻找经历过的积极事件,纠正自身不良认知,引出患者自我认同感。接下来,通过医护人员 20min 左右的访谈,邀请患者与未来的自己对话,描述期望的未来及愿景,引导患者正视抑郁症的发生、正确面对自身情绪变化,在不伤害自己的前提下进行情绪自救。指导患者利用自身资源处理目前存在的问题及困境,邀请患者认为的重要关系见证自身改变,提高同伴或家庭支持的力量。医护人员利

用 15 ~ 20 min 的时间采用案例描述的方式,向团体讲述以往相同疾病案例疾病发生发展及治疗过程,使患者对治疗更有信心,提高患者应对疾病的技能。最后,邀请观察者表达此次叙事干预的感受及想法,分享自己的故事及见解,每人叙述时间在 5 ~ 10 min,在每人分享心得结束后由医护人员进行回应及感谢。

1.3 观察指标

(1)统计 2 组患者干预前和干预后 3 个月后 NSSI 发生情况,严重程度分为无损伤、轻度(局部组织轻微伤)、中度(局部损伤需要处理)、重度(采取医疗措施)、极重度(住院治疗)。

(2)对比 2 组患者干预前后抑郁情绪,采用抑郁自评量表(SDS)^[8]和汉密尔顿抑郁量表(HAMD)^[9]分别从患者及医生角度进行评价。SDS 量表共 20 个条目,评定的时间范围为过去 1 周,按症状出现的频率分 4 个等级,没有或很少时间(1 分),少部分时间(2 分),相当多时间(3 分),绝大部分或全部时间(4 分),分数越高抑郁情况越严重。HAMD 量表由 Hamilton 于 1960 年编制,量表用 0 ~ 4 分的 5 级评分法,共包括 24 个项目,分数越高抑郁情绪越严重,总分超过 35 分就提示可能会有严重抑郁;如果总分超过 20 分,提示

可能会出现轻度到中度的抑郁;如果总分小于 8 分,提示没有抑郁症状。

(3)对比 2 组患者干预前后心理弹性及自尊水平,采用心理弹性量表(CD-RISC)^[10]和自尊量表(SES)^[11]进行评价。CD-RISC 包括 25 个项目,采用里克特氏 5 点量表评定法进行评估,分为 0 ~ 4 级,完全不正确(0 分),很少正确(1 分),有时正确(2 分),通常正确(3 分),几乎所有的时候都是这样(4 分),总分 0 ~ 100 分。SES 包括 10 个条目,总分 10 ~ 40 分。CD-RISC 和 SES 均是评分越高表示患者心理弹性及自尊越高。

1.4 统计学方法

采用统计软件 SPSS 22.0 进行数据分析处理。定性资料以 $n(\%)$ 指标进行描述,组间比较采用 χ^2 检验及秩和检验。正态分布的定量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 进行描述,观察组和对照组比较、2 组干预前后的差值比较均采用独立样本 t 检验。 $\alpha = 0.05$ 。

2 结果

2.1 患者一般资料比较

2 组患者性别、年龄、病程和自伤方式等一般资料比较,组间差异无统计学意义($P > 0.05$),见表 1。

表 1 患者一般资料比较

组别	例数	性别		平均年龄 ^① /岁	病程 ^① /月	自伤方式			
		男	女			割伤	烫伤	撞击	其他
对照组	59	22(37.3)	37(62.7)	15.72 ± 2.50	12.17 ± 3.08	21(35.6)	18(30.5)	11(18.6)	9(15.3)
观察组	59	24(40.7)	35(29.3)	15.66 ± 2.13	12.25 ± 3.41	24(40.7)	16(27.1)	13(22.0)	6(10.2)
χ^2/t		0.143		0.140	0.134			1.084	
P		0.706		0.889	0.894			0.781	

注:表中小括号前数据为例数,小括号内数据为构成比(%)。
① $(\bar{x} \pm s)$

2.2 患者干预前后 NSSI 发生情况比较

干预前,2 组患者 NSSI 频次及严重程度对比无统计学意义($P > 0.05$);干预后 3 个月,观察组患者 NSSI

频次及对身体最严重的伤害程度均明显降低,且低于对照组患者($P < 0.05$),见表 2。

表 2 患者干预前后 NSSI 情况比较

时间	组别	例数	自伤频次/月				严重程度				
			0 次	1 次	2 ~ 4 次	> 4 次	无损伤	轻度	中度	重度	极重度
干预前	对照组	59	0(0.00)	6(10.17)	26(44.07)	27(45.76)	0(0.00)	31(52.54)	23(38.98)	4(6.78)	1(1.69)
	观察组	59	0(0.00)	9(15.25)	21(35.59)	29(49.15)	0(0.00)	35(59.32)	18(30.51)	4(6.78)	2(3.39)
	Z				1.203						1.186
	P				0.548						0.756
干预后	对照组	59	12(20.34)	25(42.37)	19(32.20)	3(5.08)	16(27.12)	24(40.68)	17(28.81)	2(3.39)	0(0.00)
	观察组	59	30(50.85)	22(37.29)	7(11.86)	0(0.00)	31(52.54)	25(42.37)	3(5.08)	0(0.00)	0(0.00)
	Z				16.444						16.608
	P				0.001						0.001

注:表中小括号前数据为例数,小括号内数据为构成比(%)。

2.3 患者干预前后抑郁症状比较

干预前,2 组患者 SDS 及 HAMD 评分对比无统计学意义($P>0.05$);干预后,观察组 SDS 及 HAMD 得分均低于对照组($P<0.05$),见表 3。

表 3 患者干预前后抑郁症状比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	SDS/分			HAMD/分		
		干预前	干预后	差值	干预前	干预后	差值
对照组	59	65.42 ± 5.27	55.43 ± 4.83	10.01 ± 2.15	22.38 ± 4.15	15.47 ± 3.06	6.91 ± 1.78
观察组	59	65.51 ± 6.10	49.37 ± 4.22	16.14 ± 3.02	22.34 ± 4.28	12.26 ± 2.89	10.08 ± 2.06
<i>t</i>		0.086	7.257	12.701	0.052	5.858	8.944
<i>P</i>		0.932	<0.001	<0.001	0.959	<0.001	<0.001

2.4 2 组患者干预前后心理弹性及自尊水平比较

干预前,2 组患者 CD-RISC 及 SES 评分差异无统计学意义, ($P>.05$);干预后,观察组患者 CD-RISC 及 SES 得分均高于对照组患者 ($P<0.05$),见表 4。

表 4 患者干预前后心理弹性及自尊水平比较($\bar{x} \pm s$) 单位:分

组别	例数	CD-RISC			SES		
		干预前	干预后	差值	干预前	干预后	差值
对照组	59	62.41 ± 5.29	71.86 ± 4.61	9.45 ± 2.54	19.83 ± 3.72	26.91 ± 3.84	7.08 ± 1.53
观察组	59	62.34 ± 5.78	77.44 ± 3.52	15.10 ± 2.86	19.80 ± 3.99	31.55 ± 2.51	11.75 ± 2.12
<i>t</i>		0.069	7.390	11.346	0.042	7.769	13.720
<i>P</i>		0.945	<0.001	<0.001	0.966	<0.001	<0.001

3 讨论

青少年抑郁症是一种发病率逐年增加的精神类疾病,NSSI 作为一种常见的症状,对患者身心健康具有严重的威胁^[12]。常用的认知行为疗法主要起心理安慰作用,可暂时安慰患者负性情绪,但对抑郁症患者 NSSI 管理力度较弱,因此探索一种早期介入、积极有效的干预模式对青少年抑郁症患者康复尤为重要^[13]。“叙事”通俗来讲即为讲故事,通过叙述个人经历、梳理生命历程表达内心感受,团体叙事心理干预不仅能够通过口头诉说宣泄情感、释放内心痛苦,还能在团体干预中进行角色转换,使患者认识到与周围患者相同的经历,减轻其心理压力^[14]。

研究结果显示,干预后 3 个月,观察组患者 NSSI 频次及对身体最严重的伤害程度均明显降低,且低于对照组患者,与李承美等^[15]研究结果相同,说明对青少年抑郁症患者进行团体叙事心理干预可以降低 NSSI。目前研究中显示^[16],NSSI 患者无法识别自身的管理冲动和情绪冲动,例如寻求刺激、寻求新奇、缺乏延迟满足等,为迅速缓解不良情绪习惯性地采取非自伤性自伤行为。以往针对非自杀性自伤的管理措施多为入住封闭式病房、杜绝患者与自伤性武器的接触,但这些措施反而会增加患者不满情绪,导致患者自尊受挫,在环境解除后易重复自伤行为。本研究应用的团体叙

事心理干预充分发挥叙事干预的优势,通过个人生命故事叙说,释放内心痛苦,表达潜意识需求,并以观察者的身份认识到相同疾病患者的内心体验,矫正情绪体验与不良认知,在同伴叙事中提高负性情绪的处理能力,进而减少自伤行为。医护人员在团体叙事护理干预过程中倾听患者叙述,帮助患者梳理内心困扰,并给予鼓励、支持和陪伴,让患者尽可能多地感受到关注和理解,从而唤起患者内心积极力量。在本研究中显示,干预后,观察组 SDS 及 HAMD 得分均低于对照组,以往研究中显示^[17],叙事护理能够帮助患者回忆“特殊意义事件”,从而引导其重建积极故事,与团体干预相结合能从不同角度观察和体验过往行为,对改善不良情绪、减少自伤行为有一定积极作用,与本研究结果相同。

研究结果显示,干预后,观察组患者 CD-RISC 及 SES 得分均高于对照组,说明团体叙事心理干预能提高青少年抑郁症患者心理弹性及自尊水平。心理弹性是指行为和心理的反应状态可以根据外界环境的变化而发生改变,而青少年抑郁症患者与健康人相比,心理弹性较低,易产生负性的自动思维、自我接纳程度较低,导致自卑情结,因此提高心理弹性可防止抑郁症的发生发展,提高其自尊水平^[18-19]。本研究应用的团体叙事心理干预可通过认知重建过程帮助青少年矫正功

能不良的思维模式,重视青少年构建理想自我的需要,通过问题外化,帮助患者与自身问题分离出来,并从他人叙事中获取对自身有帮助的结果,提高了青少年抑郁症患者疾病治疗的参与度。以往研究显示^[20],团体叙事心理干预能够提高患者疾病治疗参与程度,积极地参与,也就意味着患者感受到自己的观点得到了尊重和理解,从而有利于提升其心理弹性水平,与本研究结果一致。不仅如此,本研究应用的团体叙事心理干预机制界定仪式,邀请同伴及家人见证自身疾病对抗中取得的进步,充分发挥同伴及家庭支持力度,进一步巩固和强化其积极自我认同感,提高其自尊水平及成就感。

综上所述,团体叙事心理干预能减少青少年抑郁症患者 NSSI,值得临床应用。本研究的不足之处在于研究样本有限,目前仅在本院进行了小样本研究,还仍需进一步扩大样本量进行深入研究。

参 考 文 献

- [1] ISKRIC A, CENITI A K, BERGMANS Y, et al. Alexithymia and self-harm: A review of nonsuicidal self-injury, suicidal ideation, and suicide attempts[J]. *Psychiatry Res*, 2020,288:112920. DOI: 10.1016/j.psychres.2020.112920.
- [2] HE H, HONG L, JIN W, et al. Heterogeneity of non-suicidal self-injury behavior in adolescents with depression: Latent class analysis[J]. *BMC Psychiatry*, 2023,23(1):301. DOI: 10.1186/s12888-023-04808-7.
- [3] LIU R T, WALSH R F L, SHEEHAN A E, et al. Prevalence and correlates of suicide and nonsuicidal self-injury in children: A systematic review and meta-analysis[J]. *JAMA Psychiatry*, 2022,79(7):718-726. DOI 10.1001/jamapsychiatry.2022.1256.
- [4] 马启涛,康凤英,陈琳,等. 叙事护理对青少年抑郁症患者心理弹性、自尊及服药依从性的影响[J]. *中华现代护理杂志*, 2023,29(18):2433-2440. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20220620-02958.
- [5] 赵颖逾,何叶亭,齐佳悦,等. 叙事干预对抑郁症患者焦虑、抑郁及睡眠质量的影响研究[J]. *河北医药*, 2022,44(22):3477-3479.
- [6] 舒明跃. 儿童青少年抑郁症[J]. *国外医学(精神病学分册)*, 2004,31(3):129-132.
- [7] 王继堃,赐平,刘俊升. 抑郁症主要叙事疗法的解析[J]. *医学与哲学*, 2020,41(21):50-53. DOI: 10.12014/j.issn.1002-0772.2020.21.11.
- [8] 王征宇,迟玉芬. 抑郁自评量表(SDS)[J]. *上海精神医学*, 1984(2):71-72.
- [9] 王纯,楚艳民,张亚林,等. 汉密尔顿焦虑量表的因素结构研究[J]. *临床精神医学杂志*, 2011,21(5):299-301.
- [10] 雷阳,张静平. 中文版 Connor-Davidson 心理弹性量表在糖尿病患者中的信效度研究[J]. *中国全科医学*, 2016,19(10):1188-1193. DOI: 10.3969/j.issn.1007-9572.2016.10.017.
- [11] 刘思斯,甘怡群. 生命意义感量表中文版在大学生群体中的信效度[J]. *中国心理卫生杂志*, 2010,24(6):478-482. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6729.2010.06.021.
- [12] SHAO C, WANG X M, MA Q Y, et al. Analysis of risk factors of non-suicidal self-harm behavior in adolescents with depression[J]. *Ann Palliat Med*, 2021,10(9):9607-9613. DOI: 10.21037/apm-21-1951.
- [13] TRIVEDI M H. Major depressive disorder in primary care: Strategies for identification[J]. *J Clin Psychiatry*, 2020,81(2):UT17042BR1C. DOI: 10.4088/JCP.UT17042BR1C.
- [14] 张文瑄,袁勇贵. 平衡心理治疗应用于 1 例青少年抑郁症患者的案例报告[J]. *医学与哲学(B)*, 2018,39(10):67-69. DOI: 10.12014/j.issn.1002-0772.2018.10b.19.
- [15] 李承美,倪纯纯,肖玉盼. 团体叙事心理干预对青少年抑郁症患者的影响[J]. *护理学杂志*, 2023,38(10):86-89. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2023.10.086.
- [16] 丁寒琴,杨帆,何夏君. 情绪调节策略对抑郁障碍青少年非自杀性自伤行为的影响[J]. *护理学杂志*, 2021,36(8):62-65. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2021.08.062.
- [17] 梁舜薇,刘立力,陈建斌,等. 自杀意念的叙事疗法干预个案报告[J]. *中国心理卫生杂志*, 2023,37(1):24-29. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6729.2023.01.005.
- [18] VIDAL C, LHAKSAMPA T, MILLER L, et al. Social media use and depression in adolescents: A scoping review[J]. *Int Rev Psychiatry*, 2020,32(3):235-253. DOI: 10.1080/09540261.2020.1720623.
- [19] 周晓璇,叶海森. 青少年抑郁症患者心理弹性与父母养育方式、自我接纳程度相关性分析[J]. *精神医学杂志*, 2021,34(4):304-307. DOI: 10.3969/j.issn.2095-9346.2021.04.004.
- [20] 关春兰,卜杨莹,邢乃姣. 叙事护理对抑郁症患者用药依从性及认知功能的影响[J]. *精神医学杂志*, 2022,35(1):77-80. DOI: 10.3969/j.issn.2095-9346.2022.01.016.

(收稿日期:2024-09-10)

(本文责编:林 林)